



SAÚDE COLETIVA

Janete Arcari

Revisão técnica:

Lucimar Filot da Silva Brum

Graduada em Farmácia

Mestre em Farmácia

Doutora em Ciências Biológicas (Bioquímica)



S255 Saúde coletiva / Taís de Campos Moreira... [et al.] ; [revisão técnica: Lucimar Filot da Silva Brum]. – Porto Alegre : SAGAH, 2018.

233 p. : il. ; 22,5 cm

ISBN 978-85-9502-388-8

1. Saúde coletiva. I. Moreira, Taís de Campos.

CDU 614

Organização dos serviços de saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever os princípios fundamentais da Gestão em Saúde aplicados à organização.
- Explicar os níveis de atenção à saúde.
- Identificar as Linhas de Cuidado e as redes de atenção.

Introdução

Você já imaginou o grande desafio que é organizar um Serviço de Saúde?

Reconhecer as demandas da população para então organizar a forma como cuidar melhor das pessoas é um desafio em todos os países do mundo.

Neste capítulo, você terá a oportunidade de reconhecer os conceitos que pautam a gestão em saúde em nosso país, bem como aprofundar conhecimentos a respeito dos níveis de atenção à saúde, das linhas de cuidado e das Redes de Atenção à saúde, conceitos que são utilizados hoje para a organização dos Serviços de Saúde.

Princípios organizativos do Sistema único de Saúde (SUS)

A Constituição Federal (CF) de 1988, marco da redemocratização do país, estabeleceu garantias fundamentais a todo cidadão, institucionalizando seus direitos. E é nela que se encontra a base do sistema de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS), que garante a saúde como direito de todos e dever do Estado. Essa garantia ocorre mediante o desenvolvimento de políticas sociais

e econômicas que visam à redução do risco de doença e de outros agravos. Também apresenta como princípios o acesso universal e igualitário a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação do indivíduo, assegurando a todos os cidadãos o acesso a serviços de saúde, sejam eles de atenção básica, média ou alta complexidade (BRASIL, 1988).

Além disso, o novo sistema de saúde previa uma rede regionalizada e hierarquizada, conforme a complexidade de atenção, fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. A integralidade fundamenta-se no princípio de que as pessoas têm o direito de serem atendidas no conjunto de suas necessidades, individuais e coletivas, e que os serviços de saúde devem estar organizados de modo a oferecer todas as ações requeridas para a atenção integral.

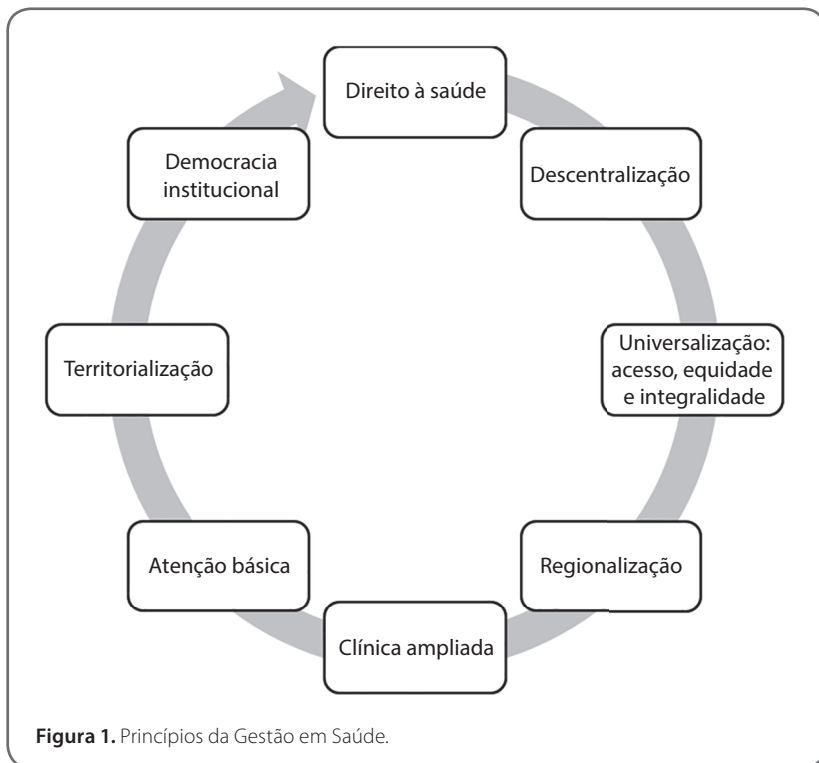
As diretrizes para a organização do sistema de saúde são fixadas no artigo 198:

[...] as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I — descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II — atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III — participação da comunidade (BRASIL, 1988, documento on-line).

O SUS propõe mudanças profundas no modelo de planejar, organizar e gerir as ações e serviços de saúde e possui um modelo de organização de serviços que traz como característica marcante a valorização no nível municipal.

Para falar sobre a organização do serviço de saúde, precisamos primeiramente entender os princípios da Gestão em Saúde que devem ser aplicados (Figura 1).



Descentralização da saúde

Ao constituir a ideia de que as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único e integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada, traz consigo uma noção que transcende a verticalidade formal político-administrativa de cada poder responsável pelo cuidado à saúde. As disputas políticas devem enfrentar o conceito de solidariedade e pactuação, respeitando a autonomia de cada poder da federação.

Nesse contexto, as ações e serviços de saúde constituem um direito social e um dever do Estado, e são gerenciados sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo (federal, estadual e municipal), conforme pacto federativo brasileiro, seguindo uma mesma doutrina e com os mesmos conceitos organizativos em todo o território nacional.

De acordo com a CF, os municípios são autônomos em relação ao Estado e à União. O Sistema deve ser alicerçado em uma relação solidária, harmoniosa, respeitando a autonomia de cada ente federado e com decisões baseadas em consenso. Não deveria haver hierarquia entre as diferentes esferas de governo. As diretrizes do novo sistema de saúde serviram de base para estruturar as mudanças necessárias, fortalecendo a descentralização, de forma que cada município passasse a gerir as ações em saúde segundo as necessidades locais (MOIMAZ et al., 2010).

Esse dever ser alicerçado em uma relação solidária constitui um dos grandes impasses na questão da regionalização, uma vez que mobiliza poderes, interesses e divergências políticas entre os níveis de governo.

No início dos anos 1990, momento em que o país vivia sob impacto da crise fiscal e da escassez de recursos, foram incluídas na agenda preocupações como a eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental e a qualidade dos serviços. Nesse mesmo período, a descentralização ganhou força: o que antes enfatizava a transferência de atribuições para ganho de eficiência, passou a integrar a dimensão de redistribuição do poder, tencionando a desburocratização e a excessiva hierarquização dos processos decisórios (FARAH, 2001).

Os municípios passam a ser os responsáveis por executar as ações e os programas de saúde, ampliar o acesso, qualificar os serviços e ordenar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) (CONASEMS, 2009), pois o trabalho da assistência e da gestão da saúde não se esgota nos limites geográficos do município.

A importância da ação municipal desde a década de 1990, principalmente na área social, chama atenção para um conjunto de abordagens inovadoras e, também, para o estabelecimento de novas esferas de participação e negociações entre os atores, nos cenários das políticas públicas.

Devido à diversidade das características dos municípios no Brasil, a descentralização ocorreu de forma heterogênea. Esse mesmo fator interferiu também na capacidade dos municípios em assumir a gestão. Mesmo assim, a descentralização favoreceu novos arranjos institucionais, como a promoção de ações intersetoriais integradas, diminuindo a fragmentação das ações, em parceria com outros níveis de governo e com governos de outros municípios.

Houve, sem dúvida, grandes avanços quanto à transferência de responsabilidades e recursos do nível federal para os estados e municípios e, com o estabelecimento de fóruns de negociação entre poderes: as comissões intergestores tripartites (CIT), bipartites (CIB) e regionais (CIR) (OUVERNEY; NORONHA, 2013).

As regiões de saúde

A regionalização do SUS foi definida pelo Ministério como estratégia prioritária para garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais; promover a equidade e a integralidade da atenção; racionalizar os gastos e otimizar os recursos; e potencializar o processo de descentralização.

A regulamentação da Lei 8.080/90, através do Decreto 7.508, estabeleceu as responsabilidades dos municípios, dos estados e da união, orientando quanto aos limites de cada ente federado na organização dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção, buscando assegurar a assistência à saúde em seus respectivos territórios(BRASIL, 1990, 2011).

A construção do Pacto pela Saúde reforçou a necessidade de intensificar o processo de regionalização da saúde como estratégia essencial para consolidar os princípios de universalidade, integralidade e equidade do SUS, sendo uma das responsabilidades gerais da gestão dos Estados “coordenar o processo de configuração do desenho da rede de atenção à saúde, nas relações intermunicipais, com a participação dos municípios da região” (BRASIL, 2006, documento on-line) e seu aprimoramento, através do Decreto 7.508/2011, promove o fortalecimento do planejamento regional, com a consequente definição das redes de atenção nas regiões de saúde.

Uma das principais inovações do Decreto 7.508 foi estabelecer os serviços mínimos que devem ser ofertados em cada Região de Saúde, sendo: serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e serviços de vigilância em saúde (BRASIL, 2011).

O Decreto estabelece a organização das relações interfederativas e reconhece as CIBs, CITs, e CIRs.

Essas comissões vão viabilizar o âmbito da gestão, decidindo de modo consensual e compartilhado a organização e a resolutividade do SUS.

Todas essas questões são de fundamental importância para dar qualidade ao Contrato de Organização de Ações Públicas (COAP). Nesse contrato fica estabelecido quais são as responsabilidades dos Municípios, dos Estados e da União para com as ações e serviços do SUS e na organização dos serviços nas Regiões de Saúde, levando em consideração as especificidades municipais, regionais e estaduais, no intuito de garantir a integralidade da assistência aos usuários.

Redes de atenção à saúde

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizadas por meio de um conjunto coordenado de pontos de atenção à saúde para prestar uma assistência contínua e integral a uma população definida. No Brasil, o tema tem sido tratado com evolução crescente. Há evidências de que as RAS melhoram os resultados sanitários e econômicos dos sistemas de atenção à saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, considera-se que não há como prescrever um modelo organizacional único para as RAS. Contudo, as evidências mostram que o conjunto de atributos apresentados a seguir são essenciais ao seu funcionamento:

1	População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e preferências, que determinam a oferta de serviços de saúde.
2	Extensa gama de estabelecimentos de saúde que prestam serviços de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados paliativos e integram os programas focalizados em doenças, riscos e populações específicas, os serviços de saúde individuais e os coletivos.
3	Atenção Básica à Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo às suas necessidades de saúde.
4	Prestação de serviços especializados em lugar adequado.
5	Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração assistencial por todo o contínuo da atenção.
6	Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da população.
7	Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo; articular as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das organizações.

(Continua)

(Continuação)

8	Participação social ampla.
9	Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico.
10	Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos pelo alcance de metas da rede.
11	Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras variáveis pertinentes.
12	Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede.
13	Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em saúde.
14	Gestão baseada em resultado.

As redes de atenção e as Linhas de cuidado

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas, que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS (BRASIL, 2012).

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral. O redirecionamento do modelo de atenção impõe claramente a necessidade de transformação permanente do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das equipes, exigindo de seus atores

(trabalhadores, gestores e usuários) maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de práticas transformadoras, a gestão das mudanças e o estreitamento dos elos entre concepção e execução do trabalho.



Saiba mais

A atenção básica deve ser responsável pelo acesso regulado aos outros níveis de atenção e a linhas de cuidado estruturadas. As linhas de cuidado servem como desenhos que expressam os fluxos assistenciais, que devem ser garantidos aos usuários atendendo as suas necessidades de saúde. As linhas definem os serviços que são desenvolvidos nos diferentes pontos de atenção da rede (nível primário, secundário e terciário) e do sistema de apoio. Elas servem como norteadoras do itinerário do usuário na rede, prevendo um conjunto mínimo de procedimentos e atividades necessários e estimulando os custos.

Atenção básica e a clínica ampliada

O Ministério da Saúde traz a clínica ampliada como uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização propõe para qualificar o modo de atenção à saúde. A clínica ampliada tem como princípio aumentar a autonomia do usuário do serviço de saúde, da família e da comunidade, e integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas na busca de cuidado e tratamento de acordo com cada necessidade, com a criação de vínculo com o usuário, considerando a vulnerabilidade e o risco do indivíduo. O diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas clínicos, mas também leva em conta a história de quem está sendo cuidado.

A clínica ampliada acontece através da escuta, buscando, junto ao usuário, os motivos pelos quais ele adoeceu, para que ele possa compreender a doença e se responsabilizar na produção de sua saúde, dando autonomia à pessoa diante do seu tratamento, ao mesmo tempo em que seu caso é tratado de forma única e singular. Por exemplo, um diabético pode e será cuidado de forma diferente de outro diabético, já que cada caso é um caso.

A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS (PNAB). O Programa Saúde da Família (PSF) surge como uma nova estratégia de atenção à saúde e de reorientação do modelo de assistência (BRASIL, 2012).



Referências

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. *Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011*. Regulamenta a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde — SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Brasília, DF, 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. *O SUS no seu município: garantindo saúde para todos*. 2. ed. Brasília, DF, 2009. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_municipio_garantindo_saude.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006*. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Brasília, DF, 2006. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html>. Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Política Nacional de Atenção Básica*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: <<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

FARAH, M. F. S. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível local de governo. *Revista de Administração Pública – RAP*, v. 35, n. 1, p. 119-144, jan./fev. 2001.

MOIMAZ, S. A. S. et al. Práticas de ensino-aprendizagem com base em cenários reais. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 14, n. 32, p. 69-79, jan./mar. 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/icse/v14n32/06.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

OUVERNEY, A. M.; NORONHA, J. C. de. Modelos de organização e gestão da atenção à saúde: redes locais, regionais e nacionais. In: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. *A saúde no Brasil em 2030: prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: organização*

e gestão do sistema de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. v. 3. p. 143-182.

Leituras recomendadas

BRASIL. Ministério da Saúde. *Mais Saúde: direito de todos 2008-2011*. 4. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios). Disponível em: <http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/mais_saude_direito_todos_4ed.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Saúde da Família no Brasil: uma análise de indicadores selecionados: 1998-2005/2006*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. *HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS*. 4.ed. 5. reimp. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.

OLIVEIRA, N. R. de C. (Org.). *Redes de atenção à saúde: a atenção à saúde organizada em redes*. São Luís: UNA-SUS/UFMA, 2015.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS